Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Traumatisme crânien

Adulte et enfant · choc à la tête observé ou suspecté · surveillance 24 h, nuit comprise

15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou se réveille mal, convulsion, membre qui ne bouge plus, parole anormale, douleur du cou ; sous **anticoagulant** ou **2 antiagrégants**, même si tout paraît normal ; somnolence, confusion nouvelle, **plus d'un vomissement** ; oubli des 30 min avant le choc ; liquide clair par le nez ou l'oreille ; enfant mou, inconsolable, somnolent.

J'applique si

- Choc à la tête observé, ou suspecté (bosse, plaie, chute sans témoin).

Je ne fais pas

- Laisser dormir toute la nuit sans réveil prévu.
- Faire boire ou manger une personne somnolente ou qui vomit.
- Antalgique « si besoin » sans validation de l'IDE.
- Attendre le matin si un signe d'alerte apparaît.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Douleur du cou : **ne pas bouger la tête**, ne pas asseoir. Ne pas laisser seule.
2. Plaie du cuir chevelu : comprimer (puis « Plaie simple ») ; bosse : froid 10 min (linge).
3. Heure du choc ? Perte de connaissance ? Éveil, parole habituels ? Mal de tête, vomit ?
4. Pouls, TA, SpO2 ; **glycémie** si diabète (AS/AP). Bleu autour des yeux ? **Anticoagulant, antiagrégant** ?
5. Prévenir l'IDE **dans tous les cas**.

ENSUITE

6. **Grille horodatée** : éveil, parole, 4 membres, vomissements, paramètres ; non communicant, enfant : comparer à l'habituel.
7. **La nuit : réveiller** aux heures de la grille (au moins 2 fois) : réveil habituel ?

Repères

Surveillance

24 h

- grille du protocole IDE « Surveillance traumatisme crânien »

IDE sans délai si

Pouls **< 50** ou **> 120**

PAS **< 100** ou **> 200**

SpO2 **< 90 %**

J'appelle l'IDE sans délai

- **65 ans ou plus sous antiagrégant** : avis médical sans délai (scanner dans les 8 h).
- Tout choc à la tête, même sans signe : l'IDE décide.
- Mal de tête croissant, un vomissement, grosse bosse, plaie ; paramètre hors repères.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, mécanisme, chaque passage de la grille, qui a été prévenu.
- Jours suivants : mal de tête croissant, confusion, chutes → IDE.

À retenir : Un traumatisme crânien peut s'aggraver dans les heures qui suivent. Anticoagulant ou deux antiagrégants = 15 ; la nuit, on réveille selon la grille.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; NICE NG232 (2023) ; Urg'ARA/ARS ARA, EHPUR, fiche Traumatisme crânien (MAJ 2025) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-TC | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature